

Kalp Damar Cerrahisi – Vaka Verileri

Abdominal Aort Anevrizması (AAA)

Alan	Değer
hastalikKey	aort-anevrizmasi
Poliklinik	Kalp ve Damar Cerrahisi
Seviye	İleri
Yaş Aralığı	65-85
Cinsiyet	Erkek

Semptom Şablonu

{yas} yaş erkek, karında nabız hissi ve sırt ağrısı

Ana Şikayet

Karında nabız atan kitle, bel ağrısı

Bilinen Bilgiler (ozetBilgiler)

- Karında nabız hissi
- Bel ve sırt ağrısı
- Hipertansiyon öyküsü
- Sigara (40 paket-yıl)

Rubrik

Beklenen Anamnez Soruları

Key	Etiket	Açıklama
-----	--------	----------

Key	Etiket	Açıklama
BATIN_KITLE	Nabız atan kitle	AAA palpasyon bulgusu
SIRT_AGRISI	Sırt ağrısı	Rüptür habercisi olabilir
HT_OYKUSU	HT	Risk faktörü
SIGARA_OYKUSU	Sigara	Risk faktörü
AILE_OYKUSU	Aile	AAA aile öyküsü

Beklenen Testler

Key	Etiket	Açıklama
BT_ABDOMEN	BT Abdomen	AAA boyutu
CBC	Hemogram	Bazal
KREATININ	Kreatinin	Kontrast öncesi
EKG	EKG	Preop kardiyak

Gereksiz Testler

Key	Etiket	Açıklama
TROPONIN	Troponin	İlgisiz

Red Flag'ler

Key	Etiket	Açıklama
RÜPTÜR_BULGULARI	Rüptür	Ani bel ağrısı + hipotansiyon
SENKOP	Senkop	Rüptür habercisi

Kabul Edilen Tanılar

- Abdominal Aort Anevrizması
- AAA

Puanlama Ağırlıkları

Davranış	Puan
----------	------

Davranış	Puan
dogru_kritik_soru	+2
dogru_yardimci_soru	+1
dogru_test	+2
gereksiz_test	-1
red_flag_atlama	-3
tehlikeli_eksik	-5
tani_dogru	+5
tani_yanlis	-3

Hasta Yanıtları

Aksiyon	Yanıt
BATIN_KITLE	Göbeğimin üstünde nabız atan şişlik var
SIRT_AGRISI	Bel ağrım var, sürekli
HT_OYKUSU	Evet, 20 yıldır tansiyon
SIGARA_OYKUSU	Günde 1 paket, 40 yıl
AILE_OYKUSU	Babamda da vardı
RÜPTÜR_BULGULARI	Ani bir ağrı olmadı
SENKOP	Bayılmadım
VITAL_TANSIYON	155/90
VITAL_NABIZ	78
VITAL_ATES	36.5°C
VITAL_SPO2	%97

Statik Test Sonuçları

Test Key	Test Adı	Sonuç	Yorum
----------	----------	-------	-------

Test Key	Test Adı	Sonuç	Yorum
BT_ABDOMEN	BT Abdomen	Abdominal aortada infrarenal 5.5 cm anevrizma, rüptür yok	İnfrarenal AAA
CBC	Hemogram	Hb: 14.0, Lökosit: 9.5	Normal
KREATİNİN	Kreatinin	1.0 mg/dL (0.7-1.3)	Normal
EKG	EKG	Sinüs ritmi, HR: 85	Normal

İdeal Klinik Yaklaşım

- Anamnez + risk faktörleri
- USG / BT: AAA çapı
- < 5.5 cm → takip
- 5.5 cm → cerrahi (EVAR / açık)

Eğitim Notu

AAA – >3 cm dilatasyon. En sık infrarenal. >5.5 cm → cerrahi endikasyon. TEDAVİ: EVAR (endovasküler) veya açık onarım. Rüptür mortalitesi %80.

Tedavi Planı

İlaçlar (yapılandırılmış)

İlaç	Doz	Yol	Endikasyon
Beta bloker	Titre edilerek	Oral	Duvar stresini azaltır
Statin	Yüksek doz	Oral	Ateroskleroz

Prosedürler

- EVAR (endovasküler anevrizma onarımı)
- Açık cerrahi onarım
- Preop kardiyak risk değerlendirmesi
- Postop BT takibi (6-12 ay)

Notlar

- < 5.5 cm → konservatif takip, yıllık USG
- Sigara bırakma zorunlu
- HT kontrolü hayati
- Aile taraması (1. derece akrabalara USG)

Kaynak

ESC 2014 Aort Hastalıkları Kılavuzu

Veri Kaynakları (KAYNAKLAR_SABLONLARI)

Bu vaka sistemimizdeki şu kaynaklara dayanır:

- Kılavuz · ESC 2014 Aort Hastalıkları → AAA tarama ve tedavi algoritması
- BT Abdomen · Sentetik → infrarenal 5.5 cm anevrizma, rüptür yok
- Laboratuvar · CBC + Kreatinin → preoperatif değerlendirme
- Demografik · 65-85 yaş erkek → AAA en sık bu grupta

Chip'ler (Soru Havuzundan)

Kategori	Chip Etiketi	Aksiyon
Şikayet & Semptom	Karında nabız var mı?	BATIN_KITLE
Şikayet & Semptom	Sırt ağrın var mı?	SIRT_AGRISI
Özgeçmiş	Tansiyon yüksekliği var mı?	HT_OYKUSU
Özgeçmiş	Kaç sigara içiyorsun?	SIGARA_OYKUSU
Özgeçmiş	Aile öyküsü var mı?	AILE_OYKUSU
Kritik Sorgulama	Ani şiddetli ağrı oldu mu?	RÜPTÜR_BULGULARI
Kritik Sorgulama	Bayılma oldu mu?	SENKOP

Sistemdeki Diğer KVC Vakaları

hastalikKey	Hastalık Adı
-------------	--------------

hastalikKey	Hastalık Adı
aort-anevrizmasi	Abdominal Aort Anevrizması
periferik-arter	Periferik Arter Hastalığı
varis	Kronik Venöz Yetmezlik (Varis)